术前评估、核对与麻醉

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

术前评估

全身 / 眼部病史、用药、家族史、围产 / 感染 / 疫苗史；视力、眼位、眼知觉 / 运动与全身检查；主诉困难需行为观察，必要安全镇静协助。

2025 刊 p501 / PDF2

三方核对与知情

沟通目的 / 预期 / 风险和患儿家属偏好；额部标眼别、眼外肌；入室医师、护士、麻醉师核身份、眼别、肌肉和术式。

2025 刊 p501 / PDF2

麻醉与高危患儿

儿童以全麻为主，眼科 / 麻醉共同评估高危并按年龄体重个体化；可配合年长且仅水平直肌后徙可局麻，均联合表麻。

2025 刊 p501 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

用药、消毒及感染禁忌

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

局麻与止血用药

常用 2% 利多卡因与 0.5% 布比卡因按 1：1 配比；无禁忌可 2.5% 苯肾上腺素点 1 或 2 次，或局麻内加 0.01% 肾上腺素 0.1~0.2 ml 。局麻总量未明确。

2025 刊 p501 / PDF2

感染与术前消毒

常规术前预防用药尚无明确定论；高风险可局部抗生素。 1% 安尔碘皮肤， 5% 聚维酮碘或 0.025% 安尔碘结膜囊 + 盐水冲洗；严重眼表 / 疑眶感染治愈后择期。

2025 刊 p501 / PDF2

药物剂量与缺项

麻醉总量 / 最大量、眼部激素频次递减、抗生素品种疗程、止吐与镇痛剂量、正式推荐等级原文未明确；不能用常识补作本共识要求。

2025 刊 p501–503 / PDF2–4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

眼心反射：原文三级阈值

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

眼心反射监测

眼球压迫 / 肌牵拉可减心率 / 心律异常；低麻醉深度、垂直肌及首条肌牵拉风险增。持续观察心率 / 血压，由麻醉 / 心内处理。

2025 刊 p502 / PDF3

心率降幅 <20%

较基线下降 <20% → 密切观察，继续手术。这里是原文眼心反射处置，不外推为其他麻醉急救阈值。

2025 刊 p502 / PDF3

心率降幅 20%~50%

若心率和血压稳定 → 按轻度观察；不稳定 → 按重度暂停 / 处理。

2025 刊 p502 / PDF3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

眼心反射升级与术中异常

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

心率降幅 >50%

立即移除斜视钩并暂停；未恢复增强局麻，再无效静推阿托品 0.1~0.3 mg，心率恢复正常后继续；由麻醉 / 心内医师处理。

2025 刊 p502 / PDF3

巩膜穿透与眼外肌异常

穿透立即局部冷凝 / 电透热，详查视网膜裂孔、必要激光 / 玻切并抗炎抗感染；断裂 / 丢失立即停止、探查、复位固定。

2025 刊 p502 / PDF3

眼前节缺血预防

避免一只眼同时做 3 条及以上直肌；既往手术 / 相邻直肌等高危，可采用保血管、折叠 / 部分腱术、必要分期。

2025 刊 p503 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

术后护理、用药和随访

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

固定随访

术后第 1 天、 1 周、 1 月、 3 月、 6 月，之后每半年；复查视力 / 屈光、眼位 / 运动 / 头位 / 双眼视，早期还看眼压和前节，按个体调整。

2025 刊 p502 / PDF3

包眼原则

不建议双眼包盖。双眼各单肌无需包眼；单眼两肌可包术眼 24 h ；双眼共≥ 3 肌可仅包反应重眼 24 h 。角膜伤可包受累眼，避免低龄长时间形觉剥夺。

2025 刊 p502 / PDF3

术后用药和眼压

抗生素 + 激素滴眼 / 眼膏；儿童推荐氟米龙替代妥布霉素地塞米松以减眼压风险，密切看眼压，常规用药 1 周后首次测压。术后仅非阿片镇痛。

2025 刊 p503 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

过矫、欠矫及感染警报

儿童斜视围手术期管理 · 2025 专家共识

外斜术后过矫

伴复视可 1~4 周交替遮盖； 4 周仍内斜 → 睫状肌麻痹验光、远视足矫 / 必要棱镜，高 AC/A 双光。连续内斜 >6 月等情况考虑二次手术 / 肉毒毒素。

2025 刊 p503 / PDF4

欠矫处理

外斜欠矫足矫近视 / 屈光参差、视功能训练；控制好观察，控制差可术后 6 周二次手术。内斜欠矫睫状肌麻痹验光、远视足矫 / 双光及治弱视。

2025 刊 p503 / PDF4

严重术后信号

嗜睡 / 食欲差，结膜红、睑肿 / 痛等须警惕眼内炎；常在 1 周内，及时眼底专科评估和抗感染、按需眼内注药 / 玻切，不能只观察常规术后反应。

2025 刊 p503 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

滑脱与其他并发症

肌肉滑脱识别

术后眼位异常、运动受限、扫视减慢应疑滑脱； MRI/ 回弹试验辅助，术中探查透见试验阳性可确诊；二次寻找实体肌并重固定。

2025 刊 p504 / PDF5

其他并发症

缝线脓肿需引流 / 培养与靶向抗生素；囊肿可激素或切除；干凹斑人工泪液 / 润滑眼膏或包眼；持续症状专业复查。

2025 刊 p503 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程｜儿童斜视围手术期管理

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2025

1 术前评估与感染筛查

严重眼表 / 可疑眶感染？是 → 治愈后择期；否 → 明确指征、全身 / 视功能评估。

2025 刊 p501

2 核对与麻醉方案

眼别 / 肌肉标记及三方核对；高危眼科 + 麻醉个体化，儿童通常全麻。

2025 刊 p501

3 术中反射分级

心率较基线降幅 <20% 观察； 20%~50% 按血压 / 心率稳定分支；>50% 立即移钩暂停。

2025 刊 p502

4 重度不恢复或组织损伤

反射按原文局麻 / 阿托品升级，由麻醉处理；穿透 / 肌断裂 / 丢失 → 立即专科处理。

2025 刊 p502

5 术后症状分支

嗜睡 / 食欲差 + 眼红肿痛 → 排眼内炎；异常眼位 / 运动受限 / 扫视慢 → 排肌滑脱；不当作普通术后反应。

2025 刊 p503–504

6 护理用药及复查

不双眼包眼； 1 周首测用药眼压； 1 天、 1 周、第 1 、 3 、 6 个月后每半年；过 / 欠矫按原文独立分支。

2025 刊 p502–503

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。